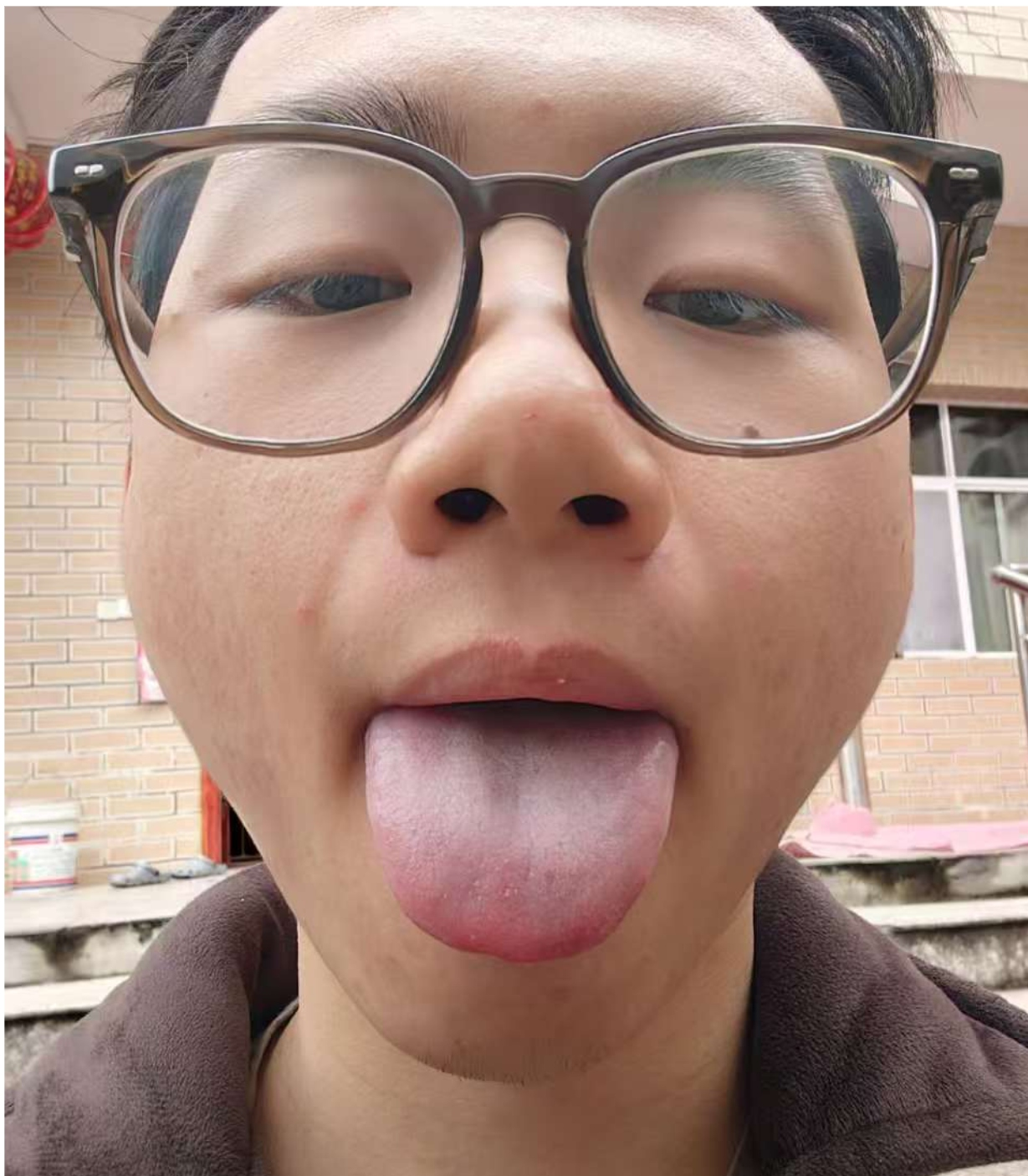


患者信息

姓名	张三丰	性别	男	年龄	19岁	生日	2006-03-23
住址	湖北省武当山特区						

四诊初步诊断

望诊（舌象分析）





舌苔图

分析提示【气滞血瘀】。特征识别：紫舌苔，舌质呈紫色，苔色深暗，多提示血瘀或寒凝血脉。

闻诊（体质诊断）

诊断结论：平和质
置信度：37.8%

体质标签：
气血充足 呼吸均匀 体质平衡
气滞血瘀 湿热体质

问诊（症状问卷）

气虚质

切诊（脉搏检测）

心率：78.1 bpm
血氧：99 %

信号有效率：100 %
采样数：50

中医建议：

【脉象】缓脉（一息四至，不快不慢，从容和缓） 【主病】平人脉象，气血调和。

综合诊断建议

根据您提供的四诊信息，现进行综合分析如下：

1. 体质判断

综合判断为 **气虚质为本，兼有血瘀、气滞。**

依据：

问诊：明确结论为“气虚质”。

望诊：舌质紫暗，提示“气滞血瘀”。

闻诊：虽结论为“平和质”，但置信度较低（0.38），且体质标签中同时包含“气血充足”与“气滞血瘀”、“湿热体质”，提示体质状态存在矛盾或兼夹，需以客观体征（舌象）和主诉（问诊）为主要依据。

切诊：脉象和缓，为平人之脉，提示当前气血运行尚属通畅，未受严重阻滞，但不足以否定舌象所提示的潜在瘀滞倾向。

2. 主要证型分析

主要症状特点：以气虚功能减退（如易疲劳、气短、自汗等）为主要表现，同时存在气血运行不畅的潜在征象（舌紫暗）。

证型判断依据：

气虚证：问诊结论直接指向气虚质，此为患者体质基础。

气滞血瘀证：望诊舌象为紫舌苔，是诊断血瘀或寒凝血脉的直接证据。气为血之帅，气虚推动无力，可导致血行缓慢而成瘀；气机不畅（气滞）亦可致血瘀。两者常相互影响。

可能的证型组合：**气虚血瘀证**。以气虚为本，血瘀为标。脉象和缓提示目前瘀滞不重，属早期或轻度阶段。

3. 调理建议

调理原则：**益气健脾为本，佐以行气活血**。

饮食调理

推荐食物：宜食性平、味甘、健脾益气的食物，如粳米、小米、山药、南瓜、红枣、莲子、牛肉、鸡肉、鲫鱼。可少量加入行气活血之品，如山楂、玫瑰花、陈皮、黑木耳、洋葱。

禁忌食物：忌食生冷、油腻、辛辣刺激及难消化的食物，如冰淇淋、肥肉、油炸食品、辣椒等，以免耗伤脾胃之气，加重湿滞。

生活起居

规律作息，避免熬夜（建议23点前入睡），保证充足睡眠以养气血。

注意保暖，尤其腹部和下肢，避免寒邪侵袭导致气血凝滞加重。

保持心情舒畅，避免思虑过度 and 情绪压抑，以防肝气郁结加重气滞。

运动保健

选择温和、持久的有氧运动，如散步、慢跑、太极拳、八段锦。以微微汗出、不觉疲劳为度。

避免剧烈、大汗的运动，以免耗气伤津。

穴位保健

足三里（双侧）：健脾益气要穴。每日用拇指按揉3-5分钟，力度以感觉酸胀为度。

合谷（双侧）：调理气机，活血通络。每日按揉2-3分钟。

血海（双侧）：专治血分疾病，有活血化瘀之效。每日按揉3分钟。

可交替按摩，早晚各一次。

中医药调理方向

若症状明显（如持续乏力、舌紫暗加重），可考虑在医师指导下用药。

方向：益气活血。可参考方剂如**补阳还五汤**（重用黄芪补气，配以活血药）或**圣愈汤**（益气补血活血）的化裁。

注意：务必经中医师辨证后开具处方，切勿自行用药。

4. 注意事项

本分析存在“舌脉不符”（舌紫提示瘀，脉缓提示和）的情况，可能提示血瘀程度尚轻，或为局部气血不畅。需密切观察舌象变化。

闻诊提示的“湿热体质”标签虽置信度低，但年轻男性仍需注意饮食清淡，避免饮酒和过度进食肥甘厚味，以防湿热滋生。

调理期间，若出现新的不适症状（如疼痛固定、刺痛感加重），应及时复诊。

5. 建议复诊周期

鉴于患者年轻，脉象基本平和，建议**1-2个月后复诊**，重新评估舌象、脉象及症状变化，以调整调理方案。

若在此期间自觉疲劳感明显加重，或舌色紫暗加深，可提前复诊。

报告生成时间：2026/3/9 15:06:37

本报告仅供参考，请在医生指导下使用。